

HUMANA

Medicina de Continuidad — formación y modelo estratégico

Documento madre del proyecto

Humana Health & Care
Versión 2.0 · Julio 2026

Contenido

Parte I · Humana Academy — La formación

Por qué Humana Academy.....	3
Qué es Humana Academy.....	3
Cómo miramos al paciente.....	3
La historia clínica es de todos.....	4
Cómo se construye el conocimiento.....	4
La misión de la Unidad de Continuidad Domiciliaria.....	4
Cómo enseñamos.....	5
Los temas que vamos a trabajar.....	5

Parte II · Humana para aseguradoras — El modelo estratégico

Los retos de las aseguradoras.....	7
Qué es la Unidad Estratégica para Aseguradoras.....	7
Cómo se diseña una Unidad Estratégica.....	8
Qué aporta Humana.....	9

Cierre

Vocabulario propio.....	10
-------------------------	----

PARTE I

Humana Academy · La formación

Por qué Humana Academy

Durante casi todo el siglo XX la medicina se organizó alrededor del episodio: una enfermedad aguda, un hospital, un diagnóstico, un tratamiento y la vuelta a casa. Ese modelo salvó millones de vidas. Pero el paciente que hoy consume la mayor parte de los recursos ya no encaja en él. Vive años con varias enfermedades a la vez. No necesita solo que lo traten: necesita que alguien conozca su historia y detecte los cambios pequeños antes de que se vuelvan grandes problemas.

El sistema sigue pensado para episodios. Nuestros pacientes viven trayectorias. Humana Academy existe para cerrar esa distancia. No enseñamos una especialidad nueva; enseñamos una forma distinta de mirar.

La medicina del episodio pregunta: «¿Qué le ocurre hoy?». La nuestra pregunta: «¿Qué cambió desde la última vez que estaba bien?».

Qué es Humana Academy

Humana Academy es un espacio de formación e intercambio clínico internacional propio de Humana, en el que participan médicos, enfermeras y demás profesionales vinculados a nuestros proyectos, sin importar el país o el territorio en el que estén. No es una formación tradicional: es una red de conocimiento construida sobre nuestra experiencia real, nuestros pacientes y nuestra metodología de trabajo.

Además de su valor formativo, refuerza la identidad común de todos los equipos y muestra que Humana dispone de una metodología propia y una red clínica internacional que comparte conocimiento de forma estructurada.

Cómo miramos al paciente

Antes que nada están nuestros principios. No son reglas: son los compromisos que elegimos sostener para mirar al paciente.

- I. La persona siempre precede a la enfermedad.
- II. Ningún paciente comienza hoy: continuamos la historia que ya existe.
- III. La situación basal es el verdadero punto de referencia: comparamos al paciente consigo mismo.
- IV. Todo cambio merece ser comprendido, incluso el que todavía no tiene nombre.
- V. Observar es un acto clínico: exige método, disciplina y lenguaje.
- VI. La información solo vale cuando cambia una decisión.
- VII. La continuidad asistencial es una responsabilidad compartida.
- VIII. Toda intervención respeta el proyecto de vida del paciente.
- IX. Cada contacto deja al sistema mejor preparado para el siguiente.
- X. Aprender nunca termina: el conocimiento se construye desde la práctica.

La historia clínica es de todos

Ningún profesional, por bueno que sea, está con el paciente las veinticuatro horas. Quien vive la enfermedad es el paciente; quien convive con ella, su familia; quien la observa cada día, el cuidador; quien la interpreta, el equipo. Cada uno ve una parte. Nuestro trabajo es unir todas esas miradas en un solo relato que no vuelva a empezar de cero cada vez que cambia un hospital o un médico.

Por eso, en Humana la historia clínica no es un documento: es una historia que se construye entre todos, y el paciente es su protagonista.

La Historia de Vida genera la Historia Clínica, y la Historia Clínica solo vale si sigue acompañando la Historia de Vida.

Cómo se construye el conocimiento

Hay una idea que queremos convertir en la imagen insignia de la Academia: el conocimiento clínico se construye por capas.

Todo empieza por la persona: quién es, cómo vive, qué le importa. Sobre ella se apoya su situación basal, es decir, cómo es cuando está estable —nuestro punto de referencia—. Después viene la observación: qué pasa hoy, sin interpretar todavía. Cuando algo se aparta de esa base aparece el microcambio, y con él la sospecha. Recién ahí interpretamos, decidimos y actuamos. Y por encima de todo, aprendemos: cada paciente cambia la forma en que cuidamos al siguiente.

La consecuencia es grande. Formar deja de ser memorizar enfermedades y pasa a ser aprender cómo se construye el conocimiento. Y la continuidad deja de depender de que atienda siempre el mismo médico: depende de que el conocimiento del paciente no se pierda nunca.

La misión de la Unidad de Continuidad Domiciliaria

Toda organización sanitaria nace para resolver un problema. Los hospitales, para los procesos agudos y la alta complejidad; la Atención Primaria, para la accesibilidad, la prevención y el seguimiento; los especialistas, para el conocimiento profundo de cada enfermedad. Pero el paciente crónico complejo transita continuamente entre todos esos niveles sin que ninguno sea realmente responsable de preservar la continuidad de su recorrido. El resultado es un sistema extraordinariamente competente para resolver episodios aislados y con serias dificultades para acompañar trayectorias largas. La Unidad de Continuidad Domiciliaria surge para cubrir ese espacio: su misión no es solo prestar asistencia en el domicilio, sino preservar la continuidad clínica, funcional y humana del paciente durante toda su trayectoria.

La enfermedad tiene episodios. La vida del paciente tiene continuidad.

Cada profesional ve solo una parte: urgencias una descompensación, el internista un ingreso, el cardiólogo una insuficiencia, la enfermera una cura, el médico de familia una consulta. Todos hacen bien su trabajo, pero cada uno mira un fotograma. El único que vive la película entera es el paciente, y con demasiada frecuencia nadie integra esos fotogramas en una historia coherente. La Unidad de Continuidad actúa como el hilo conductor de esa historia.

El paciente vive una película. El sistema sanitario vive fotografías.

El paciente crónico no permanece en una sola organización: pasa del domicilio a la primaria, a las consultas, a urgencias, a la hospitalización, a la rehabilitación, a la farmacia, a los servicios sociales, a la residencia y de nuevo al domicilio. Cada transición es un momento de riesgo, donde pueden perderse datos, cambiar tratamientos, aparecer duplicidades o deteriorarse el estado del paciente. La continuidad nunca depende de un solo profesional: es una construcción colectiva entre el paciente, la familia, los cuidadores, la primaria, los especialistas, la enfermería, la farmacia, el trabajo social y el resto de actores. La Unidad de Continuidad no sustituye a ninguno; los integra alrededor de un único plan asistencial.

La Unidad de Continuidad Domiciliaria no gestiona episodios. Gestiona la incertidumbre.

Buena parte de las consultas a urgencias no nacen de una emergencia real, sino de que el paciente o su familia no saben interpretar un cambio. La incertidumbre genera miedo, y el miedo, decisiones impulsivas. La continuidad transforma esa incertidumbre en conocimiento. Por eso la confianza no es solo un valor humano: es una intervención clínica. Y educar también es tratar: no buscamos convertir a las familias en profesionales, sino enseñarles a observar los microcambios —más cansancio, menos apetito, más somnolencia, dificultad para caminar, más confusión— que preceden a las grandes descompensaciones.

No todo problema necesita un hospital, no toda duda necesita urgencias, no toda descompensación necesita ingreso. Cuando la arquitectura funciona, cada situación va al recurso que aporta más valor, y el hospital recupera su función natural. La eficiencia económica nunca es el objetivo: es la consecuencia de una medicina mejor organizada. La Unidad de Continuidad es, al final, el elemento que mantiene unida la historia del paciente para que ninguna transición suponga una pérdida de conocimiento, de seguridad o de calidad.

Cómo enseñamos

Tenemos una forma de dar clase, y es deliberada. Enseñamos a pensar antes que a hacer: primero el criterio, después el protocolo. Trabajamos una idea por clase, en profundidad, y arrancamos siempre desde un caso real, nunca desde una definición. Contamos historias, incluidas las veces en que nos equivocamos, porque un profesional recuerda pacientes, no listas.

Y medimos el éxito de una manera incómoda: no por lo que el alumno aprendió, sino por lo que mañana va a poder observar en un paciente y ayer todavía no veía. Si al terminar una clase nadie va a hacer nada distinto, la clase todavía no terminó.

Los temas que vamos a trabajar

El conocimiento sale de lo que mejor sabemos hacer. Entre los temas que la Academia puede abordar están:

- Casos clínicos complejos gestionados por Humana.
- Experiencias de atención domiciliaria en distintos entornos sanitarios.
- Observación continua y detección precoz.
- Historia de Vida y Biografía Dinámica.
- Pulso Vital.
- Coordinación clínica longitudinal.
- El papel del cuidador dentro del modelo asistencial.

- Desarrollo y aplicación de Humana Core.
- Resultados clínicos y lecciones aprendidas.

PARTE II

Humana para aseguradoras · El modelo estratégico

Los retos de las aseguradoras

Las aseguradoras de salud atraviesan uno de los momentos de mayor transformación de su historia. El envejecimiento de la población, el aumento de la cronicidad, la inflación sanitaria, la aparición de tratamientos de alto coste, la escasez de profesionales y el crecimiento constante de la utilización de recursos están cambiando el equilibrio del sistema. La pregunta ya no es cómo seguir prestando asistencia, sino cómo sostener un modelo de alta calidad que siga siendo clínica y económicamente viable. Cinco retos concentran ese desafío.

El coste médico crece por encima de la inflación. El envejecimiento de la cartera, la pluripatología, la supervivencia prolongada, la innovación terapéutica y la mayor presión sobre hospitales y urgencias lo empujan a la vez. Como el margen para trasladarlo a las primas es limitado, la palanca real está en mejorar la eficiencia del propio modelo asistencial.

El consumo se concentra en pocos pacientes. Un grupo reducido de asegurados —de alta complejidad clínica y asistencial— concentra buena parte del gasto. El reto no es solo identificarlos, sino gobernar su trayectoria antes de que ese consumo siga creciendo.

La asistencia está fragmentada. El paciente complejo transita entre hospitales, primaria, especialistas, urgencias, residencias, domicilio y servicios sociales. Cada uno resuelve una parte; casi nadie integra el conjunto. Cada transición suma riesgo de perder información, duplicar actuaciones y tomar decisiones contradictorias. Ahí la continuidad deja de ser una prestación y pasa a ser una capacidad estratégica.

La experiencia del asegurado se juega en todo el recorrido. El asegurado no evalúa solo el resultado clínico, sino la rapidez, la coordinación, la accesibilidad, la información y la seguridad de todo su trayecto. Las poblaciones más complejas son, justamente, las de mayor riesgo de una mala experiencia.

El riesgo financiero tiene origen clínico. Cada ingreso evitable, cada descompensación, cada estancia prolongada y cada pérdida funcional es a la vez un problema clínico y económico. Gobernar el riesgo clínico significa actuar antes de que ocurran.

La respuesta no es sumar prestaciones aisladas, sino construir una capacidad permanente para gestionar poblaciones complejas: identificar, estratificar, observar, coordinar, anticipar, medir y mejorar de forma continua. Es decir, entender la continuidad asistencial como una capacidad organizativa de la aseguradora, no como un servicio que se contrata.

Qué es la Unidad Estratégica para Aseguradoras

La mayoría de las organizaciones sanitarias están diseñadas para responder a episodios. Las aseguradoras necesitan una estructura diseñada para gestionar trayectorias. No se trata solo de atender mejor, sino de organizar, coordinar, anticipar y medir mejor.

Una Unidad Estratégica para Aseguradoras es una capacidad organizativa —no una prestación adicional— diseñada para gobernar poblaciones de alto consumo y alta complejidad. No

sustituye a hospitales, primaria, especialistas ni atención domiciliaria: los integra, diseñando la arquitectura asistencial que permite que todos trabajen coordinados alrededor del paciente.

Cambia incluso las preguntas. Deja de preguntar «¿qué prestación necesita este paciente?» y empieza por «¿cuál es su riesgo?, ¿qué trayectoria sigue?, ¿qué factores aumentan el consumo?, ¿qué arquitectura asistencial necesita?, ¿quién la coordina?, ¿cómo medimos si funciona?». El foco se corre del episodio a la población. En concreto, la Unidad identifica poblaciones prioritarias, estratifica el riesgo, diseña la arquitectura, coordina los niveles asistenciales, preserva la continuidad, anticipa descompensaciones, mide resultados clínicos y económicos e impulsa la mejora continua.

Se evalúa por el valor que genera —para el paciente, para los profesionales y para la aseguradora— traducido en indicadores medibles: mejor experiencia del asegurado, mayor continuidad, menos ingresos y visitas a urgencias evitables, menor deterioro funcional, uso más eficiente de los recursos y mejor gobierno clínico de la población. La consecuencia natural es un modelo más sostenible.

Las poblaciones de alta complejidad no necesitan únicamente más recursos; necesitan una mejor arquitectura asistencial.

Cómo se diseña una Unidad Estratégica

Construir esta capacidad no es incorporar proveedores ni añadir prestaciones ni crear un programa de gestión de casos. Es diseñar una estructura capaz de gobernar longitudinalmente toda la trayectoria de la población objetivo. Ocho principios ordenan ese diseño.

1. Se construye alrededor de una población, no de una prestación. La pregunta correcta es qué necesita esa población para mantener la estabilidad clínica, funcional y asistencial durante los próximos años.
2. La arquitectura asistencial precede a la actividad. Antes de decidir quién visita o qué tecnología se usa, hay que definir quiénes entran, cómo se estratifican, quién observa, quién decide, quién coordina, cómo circula la información y cómo se mide. Sin arquitectura solo hay actividad; con arquitectura hay un sistema.
3. La continuidad debe ser una capacidad permanente, no dependiente de personas concretas: necesita procesos, protocolos, tecnología, indicadores, formación, gobierno clínico y una metodología compartida.
4. La observación es el inicio de toda decisión. Como las descompensaciones empiezan por pequeños cambios, la Unidad necesita un sistema de observación distribuida donde paciente, familia, cuidadores y profesionales aporten y la información se integre en decisiones precoces.
5. La dirección clínica gobierna la población: define criterios, prioriza riesgos, coordina decisiones, preserva la continuidad, evalúa resultados e impulsa la mejora. Es el núcleo del modelo.
6. Toda decisión debe poder medirse, con indicadores clínicos, operativos y económicos. Lo que no se mide no puede mejorarse.
7. La formación es parte de la arquitectura. Todos deben compartir un mismo lenguaje, una misma forma de observar, comunicar y decidir. La formación deja de ser complementaria y pasa a ser infraestructura.

8. La tecnología organiza el conocimiento. No sustituye al criterio clínico: lo potencia, preservando la memoria, compartiendo información, distribuyendo tareas, generando indicadores y permitiendo aprender de forma continua.

Por eso una Unidad Estratégica no debe leerse como un coste adicional ni como un proveedor más. La pregunta no es cuánto cuesta incorporarla, sino cuál es el coste de no disponer de una estructura capaz de gobernar longitudinalmente a las poblaciones de mayor complejidad. No propone gastar más: propone que cada recurso que la aseguradora ya financia genere más valor clínico, mejor experiencia y un uso más eficiente.

Qué aporta Humana

Humana no nace como una empresa de atención domiciliaria. Nace para responder cómo puede una organización sanitaria gestionar mejor a los pacientes que generan mayor complejidad, mayor consumo y mayor necesidad de coordinación. Nuestra conclusión, después de años, es que el problema no es la falta de recursos, sino la falta de una arquitectura que los organice alrededor del paciente. Por eso no desarrollamos solo actividad asistencial: diseñamos capacidades organizativas.

Nuestra misión es ayudar a las organizaciones a construir capacidades permanentes para gestionar poblaciones de alta complejidad con modelos de continuidad longitudinal. No implantamos un servicio: implantamos una forma distinta de organizar la asistencia. En concreto, diseñamos e implantamos Unidades Estratégicas para Aseguradoras, apoyadas en cinco aportes:

- **Arquitectura asistencial:** diseñamos la organización clínica alrededor de la población — criterios de inclusión, estratificación, circuitos, niveles de respuesta, responsabilidades e indicadores—.
- **Dirección clínica:** aportamos el liderazgo que gobierna el programa, prioriza riesgos, evalúa resultados e impulsa la mejora.
- **Observación distribuida:** convertimos al paciente, la familia, los cuidadores y los profesionales en una red organizada de observación, para que los microcambios se transformen en decisiones precoces.
- **Humana Core:** la infraestructura que preserva la memoria clínica, comparte información, asigna tareas, da seguimiento y genera indicadores. Más que una historia clínica: una plataforma de gobierno clínico.
- **Humana Academy:** la formación que garantiza una misma doctrina, metodología y forma de observar, comunicar y decidir en todos los profesionales.

Nuestro trabajo empieza antes de atender al primer paciente. Primero comprendemos la organización —su población, su consumo de recursos, sus patologías predominantes, su red, sus puntos de fragmentación y sus objetivos clínicos y económicos— y recién después diseñamos una arquitectura específica para ella, porque no existen soluciones universales: cada aseguradora necesita su propio modelo.

El resultado debe generar valor para todos: para el paciente, más continuidad, seguridad, mejor experiencia y calidad de vida; para los profesionales, mejor coordinación, menos fragmentación y mejor información; para la aseguradora, mejor conocimiento de su población, más gobierno clínico, uso más eficiente de los recursos y menos ingresos y urgencias evitables. Y no buscamos ser un proveedor más: diseñamos el modelo, implantamos la metodología, formamos a los profesionales, acompañamos la puesta en marcha y medimos resultados, pero la capacidad queda en la organización. Ese es el verdadero éxito del modelo.

Humana no vende atención domiciliaria: diseña, implanta y acompaña capacidades estratégicas para que las organizaciones sanitarias gestionen mejor sus poblaciones de mayor complejidad.

Vocabulario propio

Términos que usamos como nuestros y conviene sostener con el mismo sentido en todo el modelo:

Medicina de Continuidad — acompañar trayectorias, no resolver episodios sueltos.

Arquitectura Asistencial — el diseño deliberado de profesionales, recursos, relaciones y coordinación que sostiene la atención continua de una población.

Unidad de Continuidad Domiciliaria — el equipo que preserva la continuidad clínica, funcional y humana del paciente en toda su trayectoria.

Unidad Estratégica para Aseguradoras — la capacidad organizativa que gobierna poblaciones de alta complejidad con ese mismo modelo.

Situación basal — cómo es el paciente cuando está estable; el punto de referencia.

Microcambio — la pequeña desviación respecto a la basal que precede a la enfermedad.

Observación distribuida — la detección de cambios repartida entre paciente, familia, cuidadores y profesionales.

Historia de Vida / Biografía Dinámica — la biografía del paciente que da contexto y origina su historia clínica.

Pulso Vital — concepto propio de Humana, aún por desarrollar como contenido.

Humana Core — la plataforma que conserva la memoria clínica y sostiene el gobierno clínico.